

弾性ストッキング（弾性包帯）着用手順

実施中の注意点

- ・使用中は、肺塞栓症予防の観察項目に加えて、弾性ストッキングにて皮膚障害が起きていないか観察する。発赤などの皮膚症状が出現したら、P67の「弾性ストッキング着用時皮膚に発赤を認めた場合の対処」に従って発赤を評価し記録する。
- ・発赤がある場合はエスアイエイドを貼付し経過観察する。退色しない発赤がある場合や、必要時はWOCNに相談する。
- ・皮膚障害の発生を予防するため、保湿クリームを塗布してから、弾性ストッキングを装着する。
- ・患者が一人で装着可能な場合は、発赤の好発部位や神経症状などの注意点を説明し、症状がある場合はスタッフに伝えるよう説明する。

予防策の中止

- ・歩行開始後に肺塞栓症発症の危険が高いため、両下肢で立位ができ「**歩行可能**」となった翌日まで弾性ストッキングは装着し、症状がなければ翌日の日勤帯で中止する。ただし、中止の指示がない場合は医師へ確認する。
- ・高リスクレベル（人工股関節置換術・人工膝関節置換術・股関節骨折手術・骨盤骨切り術・など）の患者などは医師の指示のもと中止する。

ここでいう「歩行可能」とは

両足で立ち、歩行ができるようになった時を示し、リハビリ時のみの歩行、片側が免荷や松葉杖の使用などは含まない

記録

- ・経過表の観察項目の肺血栓塞栓症の予防から選択する。
- ・経過表に観察項目を追加し1回/日・手術当日と術後1日目は2回/日、観察する。
- ・これらの項目は、すべて症状なし（-）が正常となる。
- ・症状あり（+）になるということは、肺塞栓症の症状がある可能性があるため、必ず医師に報告する。
- ・肺血栓塞栓症予防を中止後はすべての観察項目の入力を中止する。
- ・肺血栓塞栓症が原因でない下肢痛や浮腫が出現した場合は、肺血栓塞栓症予防の観察項目とは別に観察項目を立ち上げる。
- ・中止時は、その判断となった患者の歩行状態を肺血栓塞栓症予防の看護計画で評価し、計画を中止とする。